

감기약 복용 중 다시 진료가 필요한 증상

감기(Common cold)는 대부분 며칠 안에 좋아지지만, 아래 증상은 폐렴(Pneumonia)·독감(Influenza)·코로나19(COVID-19)·기관지염(Bronchitis)·부비동염(Sinusitis) 확인이 필요할 수 있습니다. 해당되면 약만 더 드시지 말고 다시 진료를 받아 주세요.

이런 경우에는 다시 확인이 필요합니다

FEVER

고열이 나거나

38.5°C 이상 열이 지속되거나,
열이 내렸다가 다시 오르는 경우

COUGH · SPUTUM

기침·가래가 심해질 때

누런/진한 가래가 늘거나, 가래
때문에 잠을 못 자는 경우

BREATH · CHEST

숨차거나 가슴이 불편할 때

호흡곤란, 쌕쌕거림, 흉부 답답함·
흉통이 생긴 경우

WORSENING

증상이 악화될 때

좋아지다가 다시 나빠지거나 1주
이상 뚜렷한 호전이 없을 때

다시 오시면 이렇게 확인합니다

진료실 확인 항목 · CLINIC CHECK

증상 경과 — 시작일, 악화된 날짜, 좋아지다가 다시 나빠졌는지

활력징후 — 체온·맥박·산소포화도, 탈수 여부

흉부 청진 — 쌕쌕거림, 기관지염·폐렴 의심 소견

가래·콧물 양상 — 색보다 양·냄새·피 섞임·지속 기간

위험요인 — 천식·COPD·심장질환·면역저하·고령 여부

약 반응 — 해열제 반응, 복용 후 호전/악화, 부작용

필요 시 고려하는 검사 · POSSIBLE CHECKS

흉부 X-ray — 폐렴·기관지염 악화 여부 확인

산소포화도 — 숨참·쌕쌕거림이 있을 때 확인

독감·코로나 검사 — 갑작스러운 고열·몸살·접촉력

혈액검사/염증수치 — 고열 지속·전신상태 저하 시

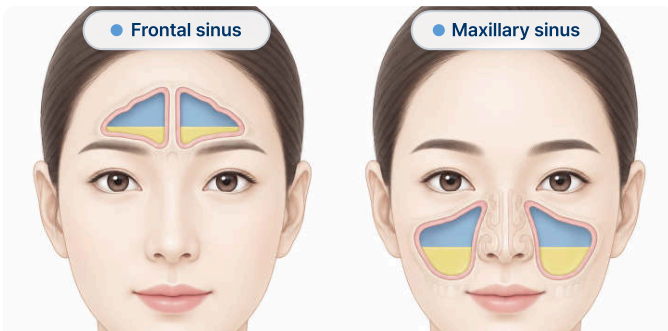
부비동염 평가 — 얼굴 압박감·코막힘·후비루가 지속될 때

천식/알레르기 평가 — 반복되는 쌕쌕거림·야간 기침

부비동염이 의심되는 증상

● Frontal sinus

● Maxillary sinus



부비동 안에 액체가 고이면 압박감·통증·코막힘이 오래 갈 수 있습니다.

특히 이런 양상이면 내원 · SINUSITIS CHECK

얼굴 통증·압박감이 심하거나 두통이 동반됨

10일 이상 코막힘·콧물·후비루가 좋아지지 않음

좋아지다가 다시 악화 — 열, 코막힘, 기침이 재상승

열이 3~4일 이상 지속되거나 전신상태가 떨어짐

반복되는 부비동염, 천식·면역저하 등 기저질환이 있음

즉시 119 또는 응급실 · EMERGENCY

숨이 차서 문장을 말하기 어렵거나 입술·얼굴이 파래짐

혼돈, 심한 어지럼, 실신 또는 깨우기 어려움

가슴 통증/압박감이 지속되거나 식은땀이 동반됨

기저질환 악화 — 천식·COPD·심부전 환자의 호흡 악화

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — CDC Common Cold 2026 · CDC Sinus Infection 2024 · CDC Flu Warning Signs 2024 · Mayo Clinic Common Cold

본 자료는 감기약 복용 중 재진이 필요한 신호를 안내하기 위한 일반 자료입니다. 개인의 나이, 임신 여부, 면역상태, 천식·COPD·심장질환 등 기저질환에 따라 더 빠른 진료가 필요할 수 있습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/respiratory/cold-return-visit/